

合理用药

给宿舍药箱上堂课

会选药 · 看成分 · 避误区

苏州大学 | 选修课课堂展示

主讲：同学甲 / 同学乙

35 分钟 · 2 位讲者 · 4 部分



室友感冒了，你先做哪一步？

A 先吃室友推荐的两种感冒药

B 先看症状、成分和注意事项

C 先加一粒抗生素，求个安心

举手选择 A / B / C | 暂不揭晓

合理用药，要同时过四关

安全

关注禁忌与不良反应

有效

针对真正需要解决的问题

经济

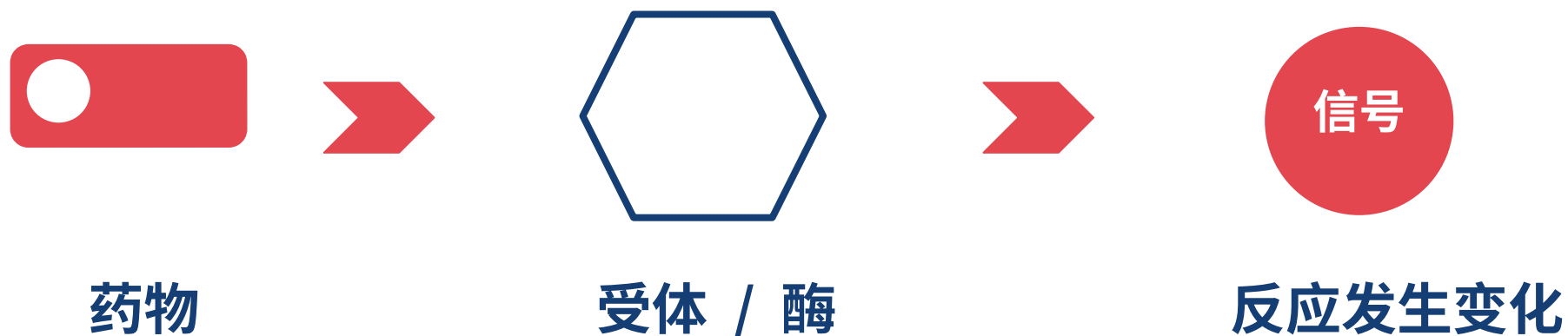
避免不必要的花费

适宜

适合这个人、这个时机

刚才选 B：先了解，再决定。

高中生物连接：药物也要找“靶点”



蛋白质的结构，与功能有关。

结构与功能有关 | 靶点也可能分布在多个部位

今天的路线：从会判断，到会行动

01

基本原则

5 分钟

02

宿舍误区

17 分钟

03

安全用药

8 分钟

04

选择挑战

5 分钟

全程约 35 分钟，已包含举手互动。

案例①：两盒感冒药，真是“双保险”？



小苏

一盒治头痛，一盒治感冒

室友

名字不同，应该能一起吃？

先暂停

翻到“成分”一栏

虚构情境 | 包装不同，成分可能重复。

看成分，才能发现“隐形重复”

教学标签 A

有效成分

对乙酰氨基酚

教学标签 B

有效成分

对乙酰氨基酚

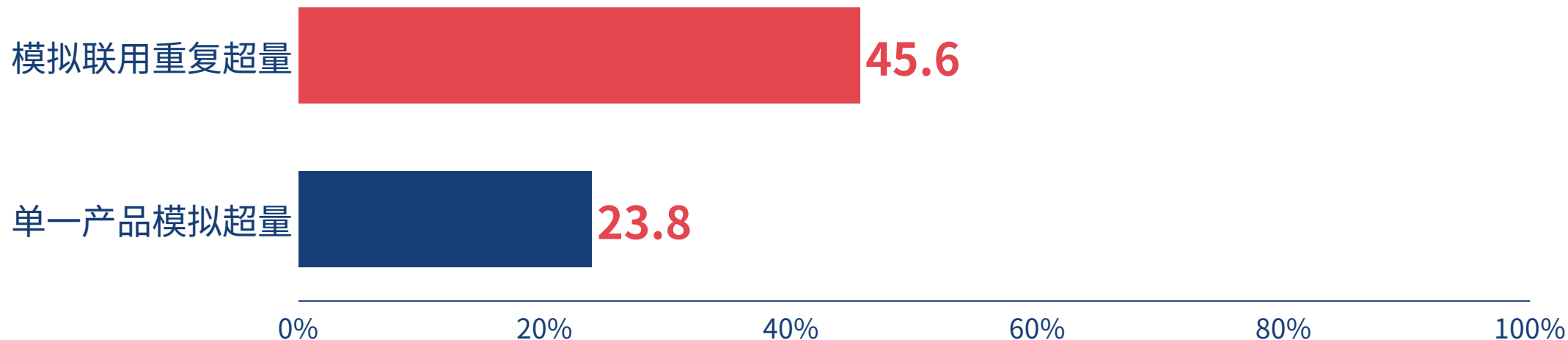
+其他成分

成分会汇合，风险不能按药盒“分开算”

通用名 / 成分优先于商品名 | 示意标签，不是实际说明书

真实研究：模拟用药，也容易出错

美国成人模拟任务 | n = 500 | 2012 年 | 单位： %



研究判断的是潜在超量风险，不是实际中毒事件。

两项指标可能重叠，不能相加；不是实际中毒率。

选择题②：两盒都含相同成分，怎么办？

- A 商品名不同，可以照常同服
- B 两种各减一半，自己调一调
- C 暂不叠加，核对说明书并问药师

请选最稳妥的下一步 | 答案在下一页

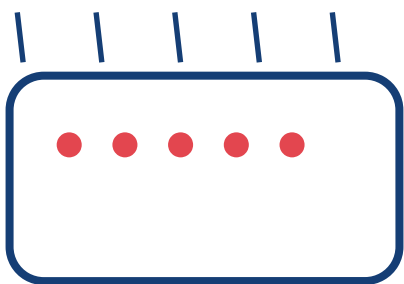
答案 C：先核对，再决定

C

- 同成分：先不自行叠加
- 规格、时间、已服药物：一起核对
- 拿不准：带包装或照片问药师

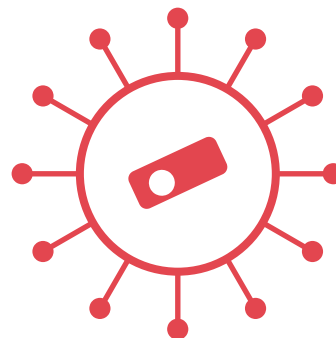
少猜一步，就少一个出错机会。

案例②：抗生素，不是感冒的通用答案



细菌

具有细胞结构
细胞壁合成等可成为靶点

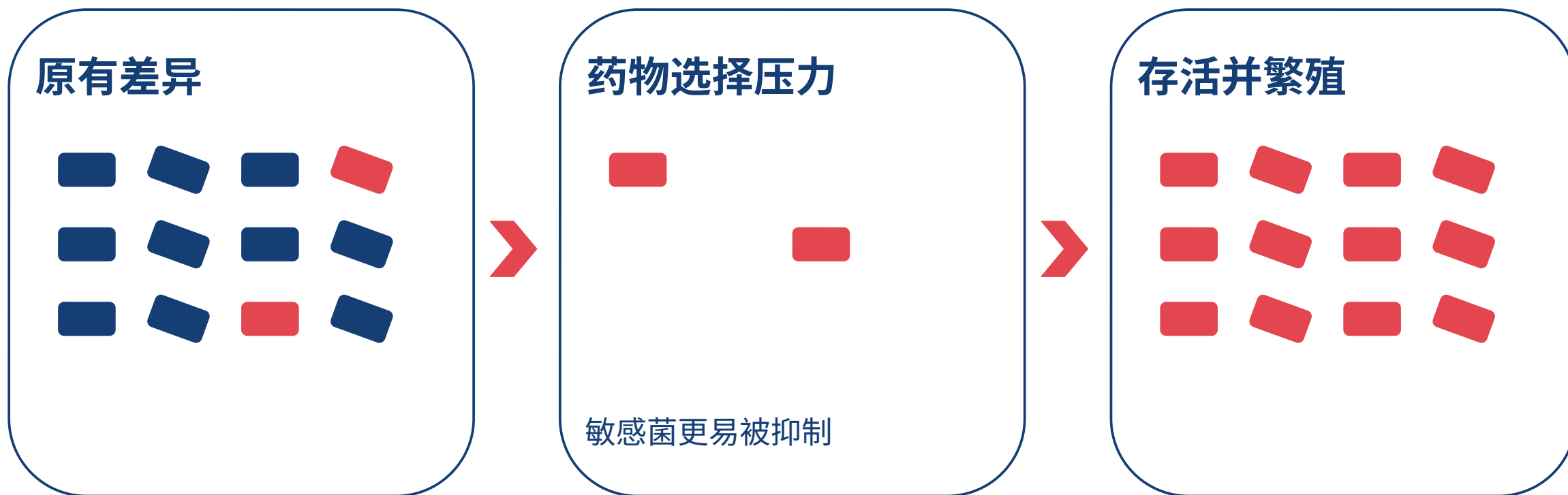


病毒

没有细胞结构
抗生素不治疗普通感冒病毒

普通感冒通常由病毒引起；是否需要抗生素，由医生判断。

耐药：被筛选出来的是细菌



蓝：敏感菌 红：耐药菌 | 数量仅为示意，不代表实验比例

连接高中生物：变异 + 选择 | 不是“人吃出了耐药体质”。

耐药风险，有多大？看清数据口径

2019 年全球细菌耐药负担 | 单位：万人 | 2022 年发表

相关死亡



区间：362—657

归因死亡



区间：91.1—171



细线表示 95% 不确定性区间

2019 年全球估计 | 两种口径，不可相加。

抗生素的三条行动规则

01

不自行启用

先明确是否需要

02

不分享剩药

相似症状不等于相同病因

03

按处方使用

不擅自停、加或延长

出现不良反应或疗效疑问，及时联系医生 / 药师。

案例③：“备考外挂”，真的值得试？



保健食品

不能代替药物治疗疾病

“提高考试成绩”

警惕夸大宣传

处方兴奋剂

不借药、不自行购买服用

清醒感，不等于学习效果的保证。

案例④：鼻子舒服了，上课却困了



部分抗组胺药

可能引起嗜睡

“较少嗜睡”

不代表人人都不困

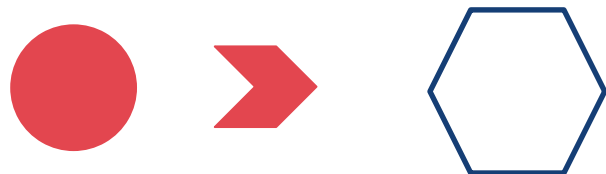
困倦时

避免驾驶、骑车等高风险活动

不能仅凭“抗过敏药”四个字判断影响。

同一条信号，在不同部位有不同作用

外周组织



组胺信号 → 参与过敏症状

脑内

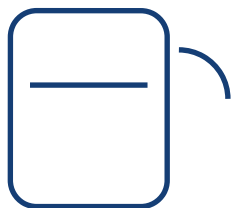
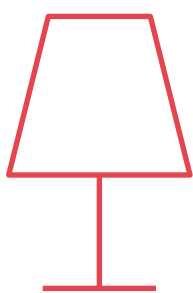


组胺信号 → 参与清醒状态

部分抗组胺药进入脑内后，可能引起嗜睡。

这是简化机制图；不能据此自行换药。

案例⑤：聚餐的酒，先缓一缓



酒精 + 部分抗过敏药

嗜睡与反应受损风险增加

酒精 + 某些药物

可能增加其他不良反应风险

普通口服片剂 / 胶囊

通常用白水，具体看说明书

**先不喝酒
再核对要求**

拿不准能否饮酒：先不喝，再查说明书或问药师。

选择题③：聚餐前，选哪条路线？

- A** 已经吃过药，统一等两小时再喝酒
- B** 看具体药品要求；拿不准就先不喝
- C** 只要不醉，就不会与药物相互作用

背景：今天服了抗过敏药，具体饮酒要求尚未确认。

安全用药四步：看、核、问、记

看

症状、说明书、就医信号

核

成分、剂量、间隔、禁忌

问

医生 / 药师，确认不确定处

记

药名、时间、用量与反应

上一题选 B | 把“不确定”变成一个咨询动作。

说明书很长？先定位这六处

1 成分 / 通用名

2 适应证或功能主治

3 用法用量

4 禁忌与注意事项

5 相互作用 / 不良反应

6 贮藏条件 / 有效期

教学阅读示意，不是实际药品说明书

六处是阅读起点，不代表其余内容可以跳过。

时间、剂量、剂型，都别凭感觉改

01

漏服

先查具体处理要求，不自行加倍

02

疗程

按处方执行，有问题及时咨询

03

剂型

缓释、肠溶等，不随意掰碎

不同药物要求不同；不要套用同一条补药规则。

问药师时，把信息一次说清



- 我有什么症状，持续多久？
- 我正在吃什么，何时吃了多少？
- 我有哪些过敏史、疾病或特殊情况？

带药盒 / 说明书照片，比“那种白色药片”更有用。

什么时候，不该继续自己试药？

120

严重急症
立即求助

呼吸困难 / 喉舌肿胀 / 意识异常

立即急救

疑似超量或误服

及时寻求医疗帮助

症状持续、加重或反复

及时就诊

严重急症拨打 120 ；带上药品信息，别等“自己好”。

宿舍药箱：留信息，也留秩序



- 原包装＋说明书 | 一起保留
- 有效期＋贮藏条件 | 定期检查
- 个人用药记录 | 不混装、不分享处方药

数量不求多；需要时能认清、查到、说清。

把五个误区，换成五个动作

01 感冒药叠加



核对成分

02 感冒吃抗生素



先明确是否需要

03 备考“外挂”



不借用处方药

04 抗过敏后困倦



查提示、避风险活动

05 吃药后聚餐



先确认饮酒要求

看、核、问、记：现在进入简单挑战。

综合挑战：小苏今晚怎么安排？



已服：一种复方感冒药

准备：再加一盒药＋参加聚餐

当前：成分没核对，症状尚轻

虚构情境 | 无呼吸困难、意识异常等急症表现。

你会替小苏选哪个方案？

- A** 两盒一起吃，聚餐少喝一点
- B** 先核对成分，拿不准问药师；先不喝酒
- C** 加抗生素预防一下，明天再看

单选 A / B / C | 想 10 秒，然后举手

答案 B：三个判断点，全都用上了

B

- 成分未核对 → 先不自行叠加
- 饮酒要求不明 → 先不喝，查询确认
- 没有用药依据 → 不自行加抗生素

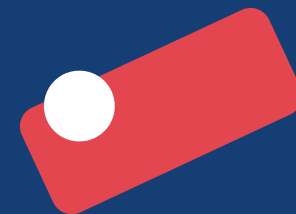
若症状加重或出现急症信号，应及时就医。

把判断带回生活

药可以常备， 判断不能省略。

先看说明书，再做用药决定
核对重复成分，记录已服药物
拿不准，问医生 / 药师

会看 · 会核 · 会问 · 会记



谢谢大家